

QUI EST QUI EN EHPAD ?

Rôles, responsabilités, bons interlocuteurs.

Guide A — Série pratique EHPAD · Culture du soin

Sommaire

1. L'organigramme réel — pas celui du livret d'accueil

Qui fait vraiment quoi, au quotidien.

2. Les profils un par un

Ce que chacun peut et ne peut pas faire pour vous.

3. Selon votre situation, à qui s'adresser

Un guide de situation rapide — problème par problème.

4. Ce que l'institution ne vous dira pas spontanément

Les réalités de fonctionnement que vous devez connaître.

5. Votre fiche de contacts à remplir

Un outil pratique à garder avec vous.

Introduction

Le jour de l'entrée en EHPAD, on vous remet un livret d'accueil. Il contient un organigramme propre, des titres officiels, des procédures. Il donne l'impression que tout est clair et fluide.

Puis vous commencez à vivre le quotidien. Et vous réalisez que vous ne savez pas à qui parler quand votre proche a une plaie qui ne cicatrise pas. Que vous ne savez pas si c'est la cadre de santé ou la directrice qu'il faut appeler quand quelque chose ne va pas. Que l'aide-soignante vous dit qu'elle "transmettra"... mais vous ne savez pas à qui, ni quand.

Ce guide est fait pour combler ce vide. Pas l'organigramme officiel. Le fonctionnement réel.

Ce que j'observe sur le terrain

La plupart des familles passent les premières semaines à ne pas savoir à qui s'adresser. Elles parlent à la première personne qu'elles croisent. Elles laissent des messages qui n'arrivent pas. Elles hésitent à déranger "la mauvaise personne". Et elles interprètent ce silence comme du désintérêt.

Souvent ce n'est pas du désintérêt. C'est juste que le message n'est pas arrivé au bon endroit. Savoir à qui parler — c'est déjà résoudre la moitié des problèmes.

1. L'organigramme réel

Un EHPAD fonctionne autour de trois grandes sphères qui coexistent, se chevauchent et parfois se heurtent : la sphère administrative, la sphère médicale et la sphère du soin quotidien. Comprendre ces trois sphères, c'est comprendre pourquoi certaines décisions se prennent là et pas ailleurs.

La sphère administrative

Elle gère le budget, les ressources humaines, les contrats, les relations avec les tutelles et les autorités de contrôle. La directrice est à sa tête. Elle décide des grandes orientations — pas des soins au quotidien.

La sphère médicale

Elle est pilotée par le médecin coordonnateur. Il supervise les projets de soins, valide les entrées et les orientations, coordonne avec les médecins traitants. Il ne prescrit pas en direct — c'est le médecin traitant qui le fait.

La sphère du soin quotidien

C'est là que se passe 90% de ce qui concerne votre proche. Elle est pilotée par la cadre de santé (ou infirmière coordinatrice selon les établissements). Elle encadre les infirmières, les aides-soignantes, les ASH. C'est votre interlocutrice principale au quotidien.

Retenez ceci : pour tout ce qui touche au soin et au quotidien de votre proche, c'est la cadre de santé qu'il faut voir en premier.

2. Les profils un par un

La directrice (ou directeur)

Ce qu'elle fait : Elle pilote l'établissement dans sa globalité. Elle est responsable légalement de tout ce qui s'y passe. Elle gère le personnel, le budget, les relations avec l'ARS et le Conseil Départemental.

Quand la voir : En cas de problème grave non résolu, de plainte formelle, ou de question concernant le contrat de séjour et la facturation. Pas pour les problèmes de soins du quotidien — elle n'a pas la main dessus.

Ce qu'elle ne peut pas faire : Elle ne peut pas modifier un protocole de soin, prescrire ou déprescrire un traitement, ni imposer une décision médicale.

La cadre de santé (ou IDEC — infirmière coordinatrice)

Ce qu'elle fait : Elle organise et supervise tous les soins. Elle gère les plannings des soignants, les transmissions, les protocoles. C'est elle qui sait ce qui se passe vraiment pour votre proche jour après jour.

Quand la voir : Pour tout ce qui concerne les soins, les comportements inhabituels, une dégradation de l'état de santé, une chute, un traitement, une demande d'adaptation du projet de soins. Elle est votre interlocutrice principale.

Astuce terrain : Demandez un rendez-vous fixé à l'avance plutôt que de l'attraper dans le couloir. Elle est très sollicitée. Un rendez-vous vous garantit du temps et une vraie écoute.

Le médecin coordonnateur

Ce qu'il fait : Il supervise la qualité médicale globale de l'établissement. Il valide les entrées, coordonne les projets de soins, fait le lien entre les médecins traitants et l'établissement. Il est aussi l'interlocuteur médical en cas de question complexe sur un traitement ou une orientation.

Ce qu'il ne fait pas : Il ne prescrit pas les traitements de votre proche — c'est le médecin traitant. Il n'est pas en contact quotidien avec les résidents.

Quand le voir : Pour des questions médicales globales, pour comprendre le projet de soins, ou si vous estimez qu'une situation médicale n'est pas bien prise en charge et que le médecin traitant est inaccessible.

Le médecin traitant

Ce qu'il fait : Il prescrit les traitements, réalise les consultations, prend les décisions médicales individuelles. Il peut être le médecin que votre proche avait avant d'entrer, ou le médecin de l'établissement.

Point important : Vous avez le droit d'être informé des décisions médicales. Si le médecin change un traitement, vous pouvez demander des explications. Si votre proche n'est plus en capacité de consentir, votre avis compte — même s'il n'est pas toujours décisionnaire.

L'infirmière (IDE)

Ce qu'elle fait : Elle exécute les prescriptions médicales, réalise les soins techniques (pansements, injections, prise de médicaments), surveille l'état de santé et transmet les observations à la cadre et au médecin.

Quand lui parler : Pour une question sur un soin spécifique, un médicament, une plaie, un changement d'état aigu. Elle peut transmettre au médecin si nécessaire.

Limite : Elle travaille sur prescription. Elle ne peut pas modifier un traitement d'elle-même, même si vous le demandez.

L'aide-soignante (AS)

Ce qu'elle fait : Elle assure les soins d'hygiène, les toilettes, les changes, l'aide aux repas, la mobilisation. C'est elle qui passe le plus de temps auprès de votre proche. Elle connaît son humeur, ses habitudes, ses petits changements.

Pourquoi elle compte : Elle est votre meilleure source d'information sur le quotidien réel. Ce qu'elle observe, elle le transmet à l'infirmière. Prendre le temps de lui parler, de lui donner des informations sur votre proche — c'est investir dans la qualité du soin.

Limite : Elle ne prend pas de décisions médicales. Si vous avez une demande importante, elle peut transmettre — mais demandez-lui à qui, et dans quel délai.

L'ASH (agent de service hôtelier)

Ce qu'elle fait : Elle assure le nettoyage des chambres et des espaces communs, aide à la distribution des repas, fait le linge dans certains établissements. Elle n'est pas formée aux soins.

Important : Dans certains établissements sous tension, les ASH sont amenés à aider à des tâches qui dépassent leur formation. Si vous observez cela et que ça vous inquiète, signalez-le à la cadre.

La psychologue

Ce qu'elle fait : Elle accompagne les résidents sur le plan psychologique, participe aux réunions de projet de vie, peut être un soutien pour les familles aussi.

Ce que peu de familles savent : Vous pouvez demander à la rencontrer vous aussi. Pas seulement pour votre proche — pour vous. Pour comprendre ce que vous traversez, ou pour naviguer une relation difficile avec l'établissement.

L'animatrice (ou animateur)

Ce qu'elle fait : Elle organise les activités, les sorties, les animations en groupe ou individuelles. Elle participe au projet de vie des résidents.

Pourquoi lui parler : Si votre proche aimait la musique, les jardins, les mots croisés — dites-le lui. C'est elle qui peut adapter les activités à ce qui compte vraiment pour votre proche.

L'assistante sociale

Ce qu'elle fait : Elle aide à la constitution des dossiers administratifs, à l'instruction des aides financières (APA, aide sociale), à la gestion des situations sociales complexes. Elle fait le lien avec les services extérieurs.

Quand la voir : Pour toute question financière, administrative, ou si vous êtes en difficulté pour payer les frais de séjour.

Chaque professionnel a un périmètre. Parler au bon interlocuteur, c'est être entendu plus vite.

3. Selon votre situation, à qui s'adresser

Guide de situation rapide — trouvez votre cas, identifiez votre interlocuteur.

Votre proche a chuté ou a une blessure

En urgence : l'infirmière de service. Pour le suivi et les explications : la cadre de santé.

Un traitement a été changé sans qu'on vous prévienne

Demandez des explications à l'infirmière. Si insatisfait : le médecin traitant directement. Si inaccessible : le médecin coordonnateur.

Vous trouvez votre proche mal soigné, sale, en détresse

Signalez immédiatement à l'infirmière ou à l'aide-soignante présente. Puis demandez un rendez-vous avec la cadre de santé le même jour ou le lendemain. Notez ce que vous avez vu, avec la date et l'heure.

Vous avez une question sur la facture ou le contrat

L'assistante sociale pour les aides financières. Le secrétariat ou la direction pour la facturation.

Votre proche s'isole, semble déprimé, perd goût à tout

Parlez-en à l'aide-soignante référente et à la cadre de santé. Demandez si la psychologue peut intervenir. Parlez aussi à l'animatrice de ce qu'il aimait faire.

Vous sentez qu'une chose grave s'est passée et qu'on vous cache quelque chose

Ne restez pas seul. Demandez un rendez-vous formel à la directrice. Mettez votre demande par écrit. Consultez le Guide F de cette série — "Quand ça coince".

Vous voulez participer davantage à la vie de l'établissement

Demandez à intégrer le Conseil de la Vie Sociale (CVS). C'est l'instance où les familles ont une voix officielle. Voyez le Guide C de cette série pour en savoir plus.

Notez toujours la date, l'heure et le nom de la personne à qui vous avez parlé. Un simple carnet change tout.

4. Ce que l'institution ne vous dira pas spontanément

Ces réalités ne sont pas des secrets. Mais elles ne sont pas non plus dans le livret d'accueil.

Le turn-over est élevé

Dans beaucoup d'EHPAD, les équipes changent fréquemment. Un soignant que vous avez appris à connaître peut ne plus être là dans deux mois. Cela veut dire que les informations sur votre proche doivent être répétées régulièrement — pas une fois à l'entrée et c'est tout.

Les transmissions ne sont pas toujours parfaites

Ce que vous dites à l'aide-soignante du matin ne sera pas forcément connu de l'équipe du soir. Le système de transmissions existe, mais il est imparfait. Pour les informations importantes, écrivez. Et vérifiez.

Il peut y avoir un soignant référent pour votre proche

Certains établissements attribuent un aide-soignant référent à chaque résident. Si c'est le cas — demandez qui c'est. C'est une personne ressource précieuse pour vous.

Les week-ends et nuits fonctionnent différemment

La cadre de santé n'est généralement pas là le week-end. Le médecin coordonnateur non plus. Les effectifs soignants sont souvent réduits. Si vous avez une inquiétude urgente un samedi soir, c'est l'infirmière de garde votre interlocutrice directe.

Vous pouvez demander accès au dossier médical

Si votre proche vous a donné accès, ou s'il n'est plus en mesure de consentir, vous pouvez demander à consulter son dossier médical. C'est un droit. La demande se fait par écrit auprès de la direction. Voyez le Guide D pour les détails.

Connaître le système ne vous rend pas suspect. Cela vous rend efficace.

5. Ma fiche de contacts à remplir

À remplir dès les premières semaines. À garder dans votre téléphone ou votre sac. À mettre à jour dès qu'un interlocuteur change.

L'établissement

Nom de l'établissement :

Téléphone standard :

Téléphone urgence nuit / week-end :

Mes interlocuteurs clés

Directrice / directeur :

Cadre de santé / IDEC :

Médecin coordonnateur :

Médecin traitant :

Aide-soignant(e) référent(e) :

Psychologue :

Assistante sociale :

Animatrice / animateur :

Notes importantes

Meilleur moment pour joindre la cadre :

Prochain rendez-vous / réunion :

Points à aborder lors de la prochaine visite :

Vous n’êtes plus un inconnu dans l’institution.

Vous savez à qui parler. C’est déjà énorme.

—

Ce guide fait partie de la série pratique EHPAD. Les autres guides de la série :

- **Guide B — Parler à l’équipe** : quand, comment, à qui, par écrit.
- **Guide C — Les réunions** : CVS, synthèses, projet de vie.
- **Guide D — Vos droits** : accès dossier, réclamation, loi.
- **Guide E — Le quotidien** : soins, repas, nuit, sorties, argent.
- **Guide F — Quand ça coince** : conflits, signalement, recours.
- **Guide G — Le changement d’EHPAD** : quand et comment partir ailleurs.

—

Et si vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé — pour décrypter une situation, préparer un rendez-vous, ou ne plus naviguer seul — je suis là.

capgrandage.fr

— *Culture du soin*